

Paciente: ADER, MANUEL

Estudio: TOMOGRAFIA DE TORAX SIN CONTRASTE ENDOVENOSO

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Médico Derivante: N/D

Fecha del Estudio: 17/03/2026 11:04:07

Procedencia: Ambulatorio

RIS A. N.: 2667865

Número de Pac.: 0002201988

Estado Informe: Final

TOMOGRAFÍA DE TORAX SIN CONTRASTE ENDOVENOSO

TOMOGRAFÍA DE SENOS PARANASALES SIN CONTRASTE ENDOVENOSO

Técnica: Se realizó tomografía multislice de tórax y senos paranasales sin contraste con cortes finos de alta resolución para mejor valoración del parénquima pulmonar.

HALLAZGOS:

Se realizó estudio comparativo con TC del día 09/03/2026.

SENOS PARANASALES

Senos paranasales libres.

Complejos ostiomeatales permeables.

Leve desviación sinuosa del tabique nasal, con componente predominante levoconvexo en el tercio medio-anterior, asociado a espolón óseo homolateral.

Cajas timpánicas y celdillas mastoideas libres.

Cavum sin particularidades.

TORAX

Se observa aislada opacidad nodulillar en segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, mide 4 mm.

No se evidencian opacidades nodulares, ni procesos de consolidación parenquimatosa actual.

El árbol tráqueo bronquial principal es de calibre y permeabilidad conservado.

No se observan adenomegalias en mediastino ni en regiones axilares.

Está conservado el calibre de los grandes vasos mediastínicos.

Port-a-cath con extremo en vena cava superior.

No se constata derrame pleural ni pericárdico.

Disminución de la densidad del pool vascular como signo de anemia, a correlacionar con laboratorio.

Edema del tejido celular subcutáneo y de la grasa mediastínica.

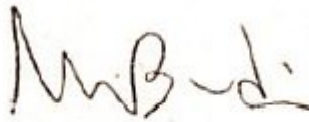
Cortes por el abdomen evidencian esplenomegalia de 145 mm en el plano axial.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

- No se reconocen hallazgos de patología aguda.



HOSPITAL BRITÁNICO
DR. CARLOS PEÑARANDA
M.N. 160.396
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES



HOSPITAL BRITÁNICO
DRA BARDIN MARIA MALENA
M.N: 203.098
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES